

体检编号：0371212402233044		
瑞慈健康体检 体检报告书		
姓 名：	杨少鹏	
性 别：	男	
检查日期：	2024-02-23	
年 龄：	34	
身 份 证：	370284198903210032	
工作单位：	招商信诺_西门子（中国）有限公司	
部 门：		
工 号：		
职 业：		

健康问卷	
项目名称	检查结果
既往史(外)	无特殊
手术史名称	无特殊
外伤史部位	无特殊
过敏	无特殊
检查医师：周锦年	

一般检查	
项目名称	检查结果
身高	174.5 cm
体重	74.7 kg
体重指数BMI	24.5
收缩压	125 mmHg
舒张压	82 mmHg
检查者：黄心怡	

内科	
项目名称	检查结果
营养	营养良好
面容	正常
胸廓	正常
心率	76 次/分
心律	齐
心音	正常
心脏杂音	无
肺部	两肺呼吸音正常
腹部	未见异常
肝脏	肋下未及
脾脏	肋下未及

下肢浮肿	无
神经反射	膝反射正常
外周血管	足背动脉搏动存在
检查医师：胡开学	

外科	
项目名称	检查结果
皮肤	未见异常
浅表淋巴结	未见异常
甲状腺	未见异常
乳房	未见异常
脊柱	未见异常
四肢关节	未见异常
肛门指诊	未见异常
前列腺	未见异常
外生殖器	未见异常
检查医师：周锦年	

眼科	
项目名称	检查结果
戴镜视力右	1.2
戴镜视力左	1.2
辨色能力	正常
右眼眼压	22 mmHg
左眼眼压	24 mmHg
外眼检查	未见异常
眼底检查	未见明显异常
科室小结	右眼眼压值偏高(22mmHg)(参考值10~21) 左眼眼压值偏高(24mmHg)(参考值10~21)
检查医师：卞宇芯	

耳鼻喉	
项目名称	检查结果
耳	未见异常
鼻	未见异常
口咽	未见异常
检查医师：沈娟英	

口腔科	
项目名称	检查结果
牙周	未见异常
口腔粘膜	未见异常
颌面部	未见异常

牙体	17缺齿
科室小结	17缺齿
检查医师：尹舒涛	

综合报告单

检验项目：尿常规				
项目名称	结果	参考值	单位	标志
尿胆原	阴性	阴性~弱阳性		
胆红素	阴性	阴性		
尿酮体	阴性	阴性		
隐血	阴性	阴性		
尿蛋白	阴性	阴性		
亚硝酸盐	阴性	阴性		
尿白细胞	阴性	阴性		
尿糖	阴性	阴性		
尿比重	1.025	1.003-1.030		
酸碱度	6.00	5.4-8.4		
维生素C	阴性	阴性		
镜检白细胞	0	0-5	Cell/HP	
镜检红细胞	0	0-3	Cell/HP	
镜检管型	0	0	Cast/LP	
镜检结晶	未见	未见	-	

审核者：蔡师珍 检查者：张艳莉 检验时间：2024-02-23 10:53:11

检验项目：生化				
项目名称	结果	参考值	单位	标志
幽门螺杆菌抗体（定量）	24.7	<40	mg/L	

审核者：陈路阳 检查者：叶琪琪 检验时间：2024-02-24 15:51:54

检验项目：免疫发光				
项目名称	结果	参考值	单位	标志
甲胎蛋白(AFP)(发光法-定量)	1.81	0--10	ng/ml	
癌胚抗原(CEA)(发光法-定量)	0.27	0--5	ng/mL	
促甲状腺激素(TSH)	1.94	0.55--5.5	mIU/L	
三碘甲状腺原氨酸（T3）	1.86	0.9--3	ng/ml	
甲状腺素（T4）	107.03	40--135	ng/ml	

审核者：陈路阳 检查者：雷娅娟 检验时间：2024-02-25 15:02:50

检验项目：生化-肝功				
项目名称	结果	参考值	单位	标志
血清总胆红素	32.89	2--20.4	μmol/L	↑

血清丙氨酸氨基转移酶	37.40	0--40	U/L	
血清天冬氨酸氨基转移酶	21.70	0--40	U/L	
血清碱性磷酸酶	68.30	46--134	U/L	
血清γ-谷氨酰基转移酶	26.20	10--60	U/L	

审核者：陈路阳 检查者：叶琪琪

检验时间：2024-02-24 15:51:54

检验项目：生化-肾功				
项目名称	结果	参考值	单位	标志
血清尿素	6.41	1.7--8.3	mmol/L	
血清肌酐	93.90	44.2--106.1	μmol/L	
血清尿酸	504.00	202--416	μmol/L	↑

审核者：陈路阳 检查者：叶琪琪

检验时间：2024-02-24 15:51:54

检验项目：生化-血糖				
项目名称	结果	参考值	单位	标志
空腹血糖	6.10	3.9--6.1	mmol/L	

审核者：陈路阳 检查者：叶琪琪

检验时间：2024-02-24 15:51:54

检验项目：生化-血脂				
项目名称	结果	参考值	单位	标志
总胆固醇	5.12	≤5.2	mmol/L	
甘油三酯	2.22	<1.7	mmol/L	↑
高密度脂蛋白胆固醇	1.12	0.9--2.19	mmol/L	
低密度脂蛋白胆固醇	3.02	<3.36	mmol/L	
动脉硬化指数（AI）	3.57	0--4		

审核者：陈路阳 检查者：叶琪琪

检验时间：2024-02-24 15:51:54

检验项目：血常规五分类				
项目名称	结果	参考值	单位	标志
白细胞	6.420	3.5-9.5	*10 ⁹ /L	
中性粒细胞百分比	56.30	50-70	%	
淋巴细胞百分比	37.00	20-40	%	
单核细胞百分比	5.70	3.0-8.0	%	
嗜酸性粒细胞百分比	0.60	0.5-5	%	
嗜碱性粒细胞百分比	0.40	0-1	%	
中性粒细胞数	3.60	2-7	*10 ⁹ /L	
淋巴细胞数	2.38	0.8-4	*10 ⁹ /L	
单核细胞数	0.37	0.12-0.8	*10 ⁹ /L	
嗜酸性粒细胞数	0.04	0.05-0.5	*10 ⁹ /L	↓
嗜碱性粒细胞数	0.03	0-0.1	*10 ⁹ /L	
红细胞	5.16	4.3-5.8	*10 ¹² /L	
血红蛋白	163	130-175	g/L	

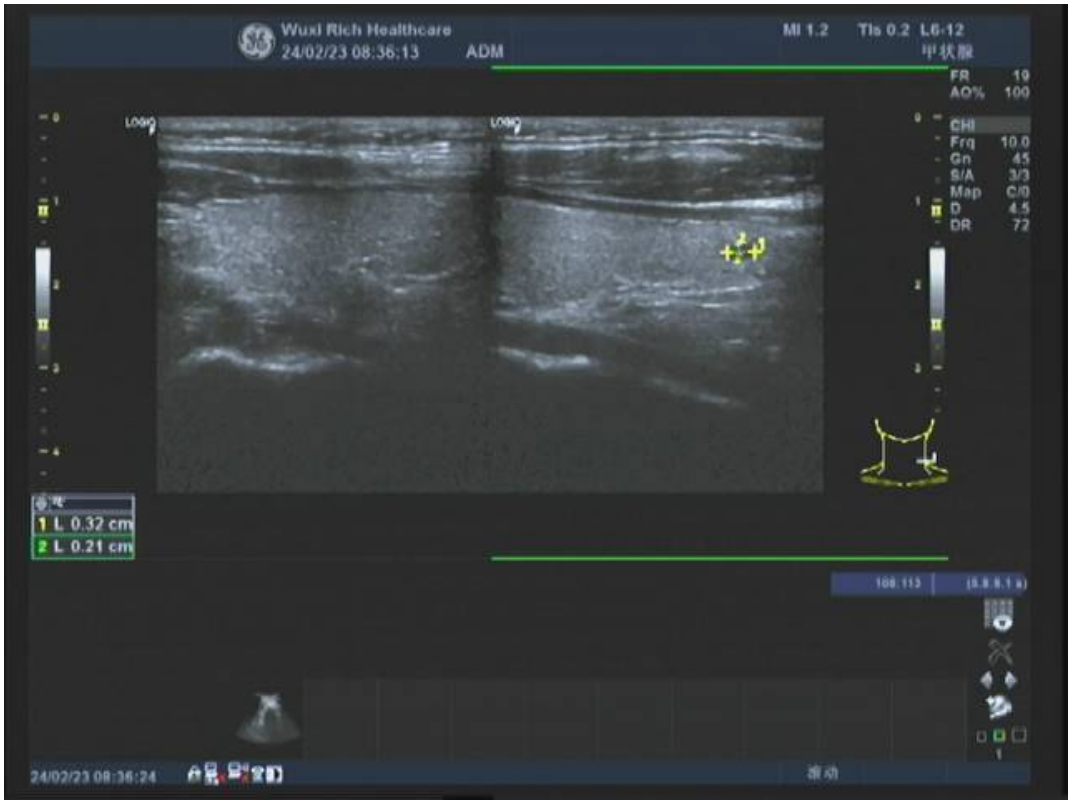
红细胞压积	45.600	40-50	%	
平均红细胞体积	88.4	82-100	fL	
平均血红蛋白量	31.6	27-34	pg	
平均血红蛋白浓度	357	316-354	g/L	↑
红细胞分布宽度-SD	36.0	21-52	fL	
血小板	222	125-350	*10 ⁹ /L	
血小板平均体积	7.6	6-13	fL	
血小板分布宽度	16.0	9-17	%	
血小板压积	0.17	0-2.9	%	

审核者：蔡师珍 检查者：张艳莉

检验时间：2024-02-23 08:39:50

彩超室	
项目名称	检查结果
检查描述	超声条件及图像质量【乙】 肝脏形态较饱满，包膜完整，回声细密，分布尚均匀，血管纹理欠清，深部回声衰减；肝内见低回声，大小约25x21mm，边界尚清，形态尚规则。CDFI：未见明显异常血流信号。 胆囊大小正常范围，胆汁透声尚可，胆囊腔内未见明显异常回声。胆总管近端未见扩张。 胰腺形态大小正常，内部回声均匀，主胰管未见扩张。CDFI：未见明显异常血流信号。 脾脏形态大小正常，包膜完整，内部回声均匀。CDFI：未见明显异常血流信号。 双肾形态大小正常范围，包膜光滑，集合系统未见明显分离。CDFI：血流灌注良好。 双叶甲状腺形态大小正常，峡部厚度正常，包膜完整，左叶内见无回声，大小约3x2mm，边界清晰，内见点状强回声后伴彗星尾征。CDFI：未见明显异常血流信号。 双侧颈动脉内径正常，管壁未见增厚，内膜光滑，管腔无明显狭窄和扩张。CDFI：显示血管充盈良好。 前列腺大小正常，包膜完整，内部回声均匀，其内未见明显异常回声。
检查结论	1.脂肪肝 2.肝内低回声，性质待定 3.左叶甲状腺滤泡扩张 4.胆、胰、脾、双肾目前未见明显占位性病变 5.双侧颈动脉未见明显异常 6.前列腺未见明显异常

影像附件1



影像附件2



影像附件3



影像附件4



影像附件5



影像附件6

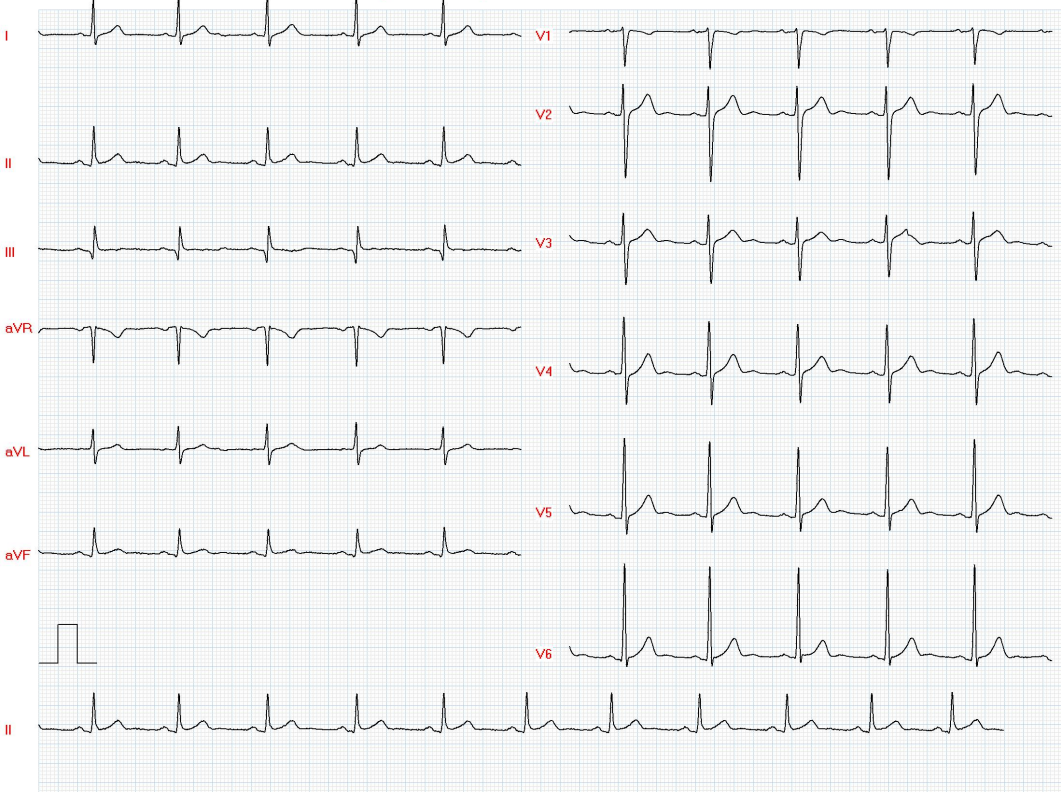


诊断医师：杨水静

放射科

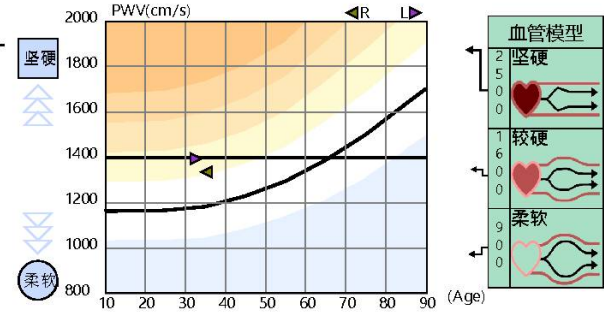
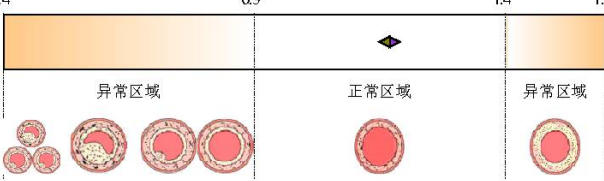
项目名称	检查结果
检查描述	两侧胸廓对称，气管居中。两侧肺野透亮度正常；两肺野纹理规整，肺内未见异常密度影。两肺门无增大、增浓；心影形态、大小正常，主动脉未见异常。纵隔居中，两膈面光整，双侧肋膈角清晰、锐利。
检查结论	心肺未见明显异常
审核医师：丁勇俊 诊断医师：汤守民	

心电图

项目名称	检查结果
检查描述	增益: 10mm/mV 走速: 25mm/s 心率: 67 bpm PR间期: 178 ms QRS时限: 95 ms QT间期: 361 ms QTc间期: 385 ms P电轴: 50 Angle QRS电轴: 41 Angle T电轴: 32 Angle RV5: 1.91 mv SV1: 0.95 mv
检查结论	窦性心律 正常心电图
影像附件1	ID号码: 0371212402233044 性别: 年龄: 增益: 10mm/mV 走速: 25mm/s 
诊断医师：肖慧卿	

影像报告

动脉硬化

申请科室:	申请医师:	本报告单仅提供临床参考, 不作为诊断依据	
无锡瑞慈瑞锡门诊部 动脉硬化检查报告		病历号: 0371212402233044	检查号: 16967
		姓名: 杨少鹏	性别: 男
		年龄: 34 岁	
		身高: 175.0 cm	体重: 75.0 kg
		BMI: 24.5	
血压值 mmHg 上臂(右) 119 / 71 上臂(左) 114 / 73 脚踝(右) 137 / 66 脚踝(左) 142 / 67			
您的动脉硬化吗(baPWV)? 右:1341 左:1397 与健康34岁男性比较: 正常范围内 *baPWV主要检测肢体血管动脉硬化, 不能反映脑血管或心脏血管硬化情况。  血管模型 2 坚硬 5 0 0 1 较硬 6 0 0 9 柔软 0 0 0			
您的动脉阻塞吗(ABI)? 右踝:1.15 左踝:1.19 本次检查结果在正常范围内。  异常区域 正常区域 异常区域			
检查所见 双侧上肢血压正常; 双侧上肢血压无明显差异; 双侧上肢脉压正常; 双侧下肢血压无明显差异; 双侧下肢脉压增大; 双侧下肢静态ABI在正常范围; 双侧上肢静态BAI在正常范围; 双侧baPWV正常范围; 四肢动脉脉搏波形未见异常。		诊断所见 外周动脉检测未见异常。	
操作者: 		医师签名: 	

检查日期: 2024-02-23

地址: 无锡市滨湖区湖滨路688号华东大厦

型号: VBP-9A

电话: 0510-859812688

终检结论

1.超重。体重指数BMI值偏高(24.5)(参考值18.5~23.9)。建议合理膳食、强度适中的运动, 控制体重。

【超重与肥胖】体重超标包括超重与肥胖。体重指数(BMI)=体重(kg)/身高(m)的平方, BMI $\geq$ 24为超重, BMI $\geq$ 28为肥胖; 男性腰围 $\geq$ 90cm和女性腰围 $\geq$ 85cm为腹型肥胖。体重超标是一种由多因素(如遗传、进食油脂较多、运动少、疾病等)引起的慢性代谢性疾病, 尤其是肥胖, 已经被世界卫生组织列为导致疾病负担的十大危险因素之一。建议: 采取综合措施预防和控制体重, 积极改变生活方式, 宜低脂、低糖、高纤维素膳食, 多食果蔬及菌藻类食物, 增加有氧运动。若有相关疾病(如血脂异常、高血压、糖尿病等)应积极治疗。

2.右眼眼压值偏高(22mmHg)(参考值10~21); 左眼眼压值偏高(24mmHg)(参考值10~21)。建议眼科进一步检查。

3.17缺齿。建议口腔科随诊。

4.高尿酸血症。血清尿酸值(504.00 μ mol/L)(参考值202--416)。建议调整饮食结构, 以低嘌呤食物为主, 内分泌代谢科诊治。

【高尿酸血症】尿酸作为嘌呤代谢的终产物，生成过多，或肾脏排泄减少均可使其升高。肥胖、高脂血症、高血压、冠心病及长期服用降压利尿药者亦可导致高尿酸血症。可分为原发性和继发性高尿酸血症。无症状性高尿酸血症可以没有关节炎、痛风等症状。高尿酸血症中，大约10%-20%可发展为痛风。建议您：（1）低嘌呤饮食、戒酒，多饮水。（2）重视健康体检。（3）适当运动，控制体重。（4）慎用可能影响尿酸排泄和使尿酸升高的药物。（5）内分泌代谢病科或风湿病科就诊。

5.血脂异常。甘油三酯值偏高(2.22mmol/L)(参考值<1.7)。建议控制饮食和健康的生活方式，心内科随诊。

【血脂异常】是一类较常见的疾病，是人体内脂蛋白的代谢异常，主要包括总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯升高和或高密度脂蛋白胆固醇降低等。血脂异常是导致动脉粥样硬化的重要因素之一，是冠心病和缺血性脑卒中的独立危险因素。引起血脂异常的原因：（1）饮食不科学。（2）生活无规律，体力活动减少。（3）患有某些代谢性疾病，如肥胖症、糖尿病、遗传疾病等。健康体检发现血脂异常者应注意：（1）调整膳食结构。（2）加强体育锻炼，控制体重。（3）戒烟，控酒。（4）控制影响血脂的其他疾病，如糖尿病等。（5）对于40岁以上的中老年人或者血脂异常合并高血压、糖尿病、冠心病等危险因素者，应定期检测相关指标。经上述方法调整仍不理想，建议在医生指导下用药。

6.空腹血糖受损。空腹血糖(6.10mmol/L)。建议合理膳食、强度适中的运动，内分泌代谢科复查空腹血糖或口服葡萄糖耐量试验（OGTT）。

【空腹血糖受损】是指空腹血糖在 $\geq 6.1\text{mmol/L}$ < 7.0mmol/L 之间，既高于正常标准又低于糖尿病诊断标准之间的一种亚健康状态。可进一步检查餐后2小时血糖和糖化血红蛋白。空腹血糖受损还不是疾病，但已经有血糖调节异常，它是一种危险状态，很可能发展成糖尿病。因此要积极干预，防止发生恶性事件。与糖尿病不同，空腹血糖受损有很大可逆性，如果采取有效措施，糖耐量可以恢复正常。主要干预措施是：（1）控制饮食，减少总热量。吃低脂、低糖、低盐、高纤维素饮食。（2）合理运动，减轻体重，消除将军肚（腹型肥胖）。（3）保持生活环境稳定，精神愉快，避免过度焦虑和紧张。（4）密切监测血糖变化。

7.肝功能提示：血清总胆红素值偏高($32.89\mu\text{mol/L}$)(参考值2--20.4)。建议消化内科复查。

【血清总胆红素偏高】血清胆红素是体内衰老红细胞裂解而释放出的血红蛋白产生的，包括间接胆红素与直接胆红素，总胆红素是直接胆红素和间接胆红素之和。肝脏在胆红素代谢中具有摄取、结合和排泄功能，其中任何一种功能障碍均可引起黄疸。血清总胆红素（包括直接胆红素和间接胆红素）测定反应了黄疸的程度。增高常见于肝细胞损害、胆道梗阻和溶血性疾病。建议您复查肝功能，消化内科就诊。

8.超声提示：脂肪肝。建议消化内科随诊。

【脂肪肝】是指肝细胞脂肪堆积过多和脂肪变为特征的临床病理综合征。常见的病因有肥胖、酒精、营养不良、药物等。肥胖、2型糖尿病、高脂血症等往往成为脂肪性肝病的易感因素。轻度脂肪肝可无症状，少数可有乏力、右上腹轻度不适、肝区隐痛或上腹胀痛等。中、重度者肝肿大，血清转氨酶升高。部分可发展到肝硬化。超声是诊断脂肪性肝病重要手段。治疗主要是针对原发病及调整饮食结构等综合措施。单纯性脂肪肝和脂肪性肝炎可以逆转乃至完全恢复，部分患者需在医生指导下药物治疗，消化内科随诊。

9.超声提示：肝内低回声，性质待定。建议肝胆外科进一步检查。

10.超声提示：左叶甲状腺滤泡扩张。建议内分泌代谢科/甲状腺外科随诊。

11.动脉硬化结果详见报告。

主检医师：吴敏艳 初审医师：高雪芬



终审日期：2024-02-28 10:18:07 初审日期：2024-02-27 09:36:51

报告解读

体检报告解读方式：

- （1）现场咨询：到体检机构客服部当面咨询。
- （2）电话咨询：按体检报告底部右下方显示电话号码致电体检机构咨询。
- （3）致电瑞慈服务热线4001688188转接预约咨询。
- （4）微信小程序在线解读报告:扫一扫右侧小程序二维码，在线解读报告。



备注：具体咨询时间以体检机构告知为准；由于体检业务繁忙，高峰时段，可能会有医生无法立即接待、座机无法及时接听的情况，敬请客户谅解。

微信扫一扫，解读报告

电话:0510-85912688